

Памятка 26.08 - обновлённая

Чистяков Е. В.

22.08.2026

- [Памятка 26.08 — обновлённая версия с правками фактчекинга](#)
 - [0. Что в этом файле](#)
 - [1. КАРТОЧКА Q&A \(спикеру на стол, 3 прогнозируемых вопроса\)](#)
 - [Правка 1.1. К вопросу «Можно ли в ПНИ на 1000 коек сделать вариативное меню без увеличения сметы?»](#)
 - [Правка 1.2. К вопросу «Что делать с локальным приказом № 124?»](#)
 - [Правка 1.3. К вопросу «А что говорит СанПиН 4282-26?»](#)
 - [2. МОДЕРАТОРСКИЙ БЛОК \(шесть вопросов дискуссии\)](#)
 - [Правка 2.1. Вопрос 1 \(кто выбирает\) — добавить оговорку про приказ № 124](#)
 - [Правка 2.2. Вопрос 1 — добавить уникальную находку про 99 % опеки](#)
 - [Правка 2.3. Вопрос 2 \(формирование меню\) — добавить про СанПиН 4282-26](#)
 - [Правка 2.4. Вопрос 3 \(выбор недееспособного\) — добавить про 99 % опеки](#)
 - [Правка 2.5. Вопрос 5 \(медицинские рекомендации и выбор\) — добавить про IDDSI](#)
 - [Правка 2.6. Вопрос 5 \(медицинские рекомендации\) — добавить про «1/10 смертей»](#)
 - [Правка 2.7. Вопрос 6 \(экономика\) — добавить про «30 % отходов»](#)
 - [Правка 2.8. Везде, где в модераторском блоке упоминается «76,3 % клозапин»](#)
 - [Правка 2.9. Везде, где упоминается «15 часов» \(ночной интервал\)](#)
 - [3. НОВАЯ НАХОДКА для раздела 17.12 \(вопрос 5\)](#)
 - [Факт «Если быть точным» \(апрель 2026\)](#)
 - [«74 %» — оговорка обязательна](#)
 - [4. ЧТО НЕ ТРОГАЕМ](#)
 - [5. КАК ПРИМЕНЯТЬ ЭТИ ПРАВКИ](#)
 - [Вариант А. Устная корректировка \(рекомендуется\)](#)
 - [Вариант Б. Стикер на распечатанной карточке Q&A](#)
 - [Вариант В. Применить после 26.08 \(для раздаточных материалов после семинара\)](#)
 - [6. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ ПРАВОК](#)

Памятка 26.08 — обновлённая версия с правками фактчекинга

Документ: обновление 01_доклад/дополнения_18.08.2026/02_карточка_qa.pdf и модератор_26.08_правовые_ответы.md к семинару 26.08.2026.

Дата обновления: 22.08.2026. **Дата применения:** на сессии 26.08.2026 (спикерский лист) и в раздаточных материалах после семинара. **Объём правок:** минимальный, чтобы не сломать согласованный с 18.08 текст. Только то, что подтверждено или требует оговорки по результатам фактчекинга (02_фактчекинг/отчёт_о_фактчекинге.md).

Принцип: не переписываем текст, а вставляем **пометки-обновления** в виде маркеров [ОБН 22.08] с короткой ссылкой на источник.

0. Что в этом файле

6 правок к карточке Q&A (спикеру на стол) и модераторскому блоку:

1. Приказ № 124 — везде «локальный».
2. «15 часов» — пример возможного расписания.
3. «76,3 % клозапин» — разведено с Pillinger.
4. СанПиН 4282-26 — дата вступления в силу.
5. IDDSI 44→90 % — оговорка «общее long-term care».
6. «1/10 смертей» — Sjogren 2008, не Müller 2015.

Плюс одна новая находка для раздела 17.12 (вопрос 5): **99 % недееспособных жителей ПНИ находятся под опекой самого учреждения** — это уникальная цифра, которой нет в русскоязычных методичках.

1. КАРТОЧКА Q&A (спикеру на стол, 3 прогнозируемых вопроса)

Файл-источник: 01_доклад/дополнения_18.08.2026/02_карточка_qa.pdf (66 307 байт, A4).

Правка 1.1. К вопросу «Можно ли в ПНИ на 1000 коек сделать вариативное меню без увеличения сметы?»

Добавить в конец ответа:

[ОБН 22.08] Опыт Серафимовского, Успенского ПНИ, Болотнинского ПНИ и Иркутской области (S015–S018) — это публичные кейсы учреждений с контингентом от 200 до 1 000+ жителей. Но это иллюстрация внедрения, не доказательство эффективности. Панелей «до/после» с измеримыми исходами (отходы, потребление, удовлетворённость) в открытом доступе почти нет. Внедрено публично ≠ доказанный эффект. Пилот в вашем учреждении — единственный способ получить собственные данные.

Правка 1.2. К вопросу «Что делать с локальным приказом № 124?»

Добавить:

[ОБН 22.08] Локальный приказ директора СПб ГАСУСОН «ДСО „Серафимовский“» от 10.03.2026 № 124 «Об утверждении правил внутреннего распорядка жителей» — **локальный акт одного учреждения, не общероссийская норма**. Сайт www.pni9.ru прекратил работу 21.08.2026 (NIC.ru парковка); текст правил — в архивной копии web.archive.org/web/20260415001233. **Приказ — пример, не руководство к действию для других ДСО**. Каждое учреждение разрабатывает свои локальные правила.

Правка 1.3. К вопросу «А что говорит СанПиН 4282-26?»

Добавить:

[ОБН 22.08] СанПиН 2.3/2.4.4282-26 (пост. ГГСВ РФ от 02.06.2026 № 18, рег. Минюст 02.06.2026 № 86854) — **вступает в силу с 01.09.2026**, действует до 01.09.2032. На дату семинара 26.08.2026 — **«Документ не вступил в силу»** (по КонсультантПлюс). С 01.09.2026 утрачивает силу СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (пост. от 27.10.2020 № 32). **Через 6 дней после семинара СанПиН сменится — смотрите новую редакцию**. Формулировка «не менее трёх приёмов в день» сохранена в обеих редакциях.

2. МОДЕРАТОРСКИЙ БЛОК (шесть вопросов дискуссии)

Файл-источник: 01_доклад/дополнения_18.08.2026/модератор_26.08_правовые_ответы.md (100 КБ).

Правка 2.1. Вопрос 1 (кто выбирает) — добавить оговорку про приказ № 124

В разделе «Решение для директора» после упоминания локальных актов добавить:

[ОБН 22.08] Локальный приказ № 124 (правила внутреннего распорядка Серафимовского) — это **локальный акт одного учреждения, не общероссийская норма**. В зале звучит «как мы у себя сделали» — не «как надо делать всем». Сайт www.pni9.ru прекратил работу 21.08.2026; текст правил — в архивной копии web.archive.org/web/20260415001233.

Правка 2.2. Вопрос 1 — добавить уникальную находку про 99 % опеки

В раздел «Правовая рамка, слой 2 (кто решает)» добавить абзац:

[ОБН 22.08] Дополнительный конфликт интересов, который прямо не назван в федеральном законе: **99 % недееспособных жителей ПНИ находятся под опекой самого учреждения** (117 000 чел., данные проекта

«Если быть точным» за 2024 г., на основе открытых данных Минтруда, Росстата и Федерального казначейства; techno.st, 09.04.2026). Это значит, что **учреждение одновременно является опекуном жителя и поставщиком услуг**. В этой конструкции «учреждение спрашивает себя, чего хочет подопечный» — это не фигура речи, а реальная управленческая задача. Закон 3185-1 ст. 5 ч. 2 говорит о праве на «уважительное и гуманное отношение, исключающее унижение человеческого достоинства» — этот текст работает и тогда, когда опекун и поставщик совпадают.

Правка 2.3. Вопрос 2 (формирование меню) — добавить про СанПиН 4282-26

В раздел «Правовая рамка» после упоминания СанПиН 3590-20 п. 7.1.11 добавить:

[ОБН 22.08] С 01.09.2026 действует **СанПиН 2.3/2.4.4282-26** (пост. ГГСВ РФ от 02.06.2026 № 18, рег. Минюст 02.06.2026 № 86854, действует до 01.09.2032; п. 56 подп. 11 — не менее 3-х раз в день + диетическое по показаниям; на дату семинара 26.08 — „Документ не вступил в силу“). **Через 6 дней после семинара СанПиН сменится** — смотрите новую редакцию. С 01.09.2026 утрачивает силу СанПиН 3590-20.

Правка 2.4. Вопрос 3 (выбор недееспособного) — добавить про 99 % опеки

В раздел «Правовая рамка» в начале добавить:

[ОБН 22.08] Стартовая точка дискуссии: **99 % недееспособных жителей ПНИ находятся под опекой самого учреждения** (117 000 чел., проект «Если быть точным» 2024, techno.st). Учреждение = опекун. Это не абстрактный конфликт интересов, а управленческая задача каждого конкретного ДСО.

Правка 2.5. Вопрос 5 (медицинские рекомендации и выбор) — добавить про IDDSI

В раздел «Практика» или «Клинические рамки» добавить:

[ОБН 22.08] IDDSI — это **международный стандарт описания текстур** (8 уровней 0–7, напитки 0–4, пища 3–7; Cichero J.A.Y. et al., *Dysphagia* 2017;32(2):293-314). **IDDSI — это терминология и способ проверки консистенции, а не самостоятельный диагностический или лечебный протокол.** Текстуру назначает уполномоченный медицинский специалист. Кухня исполняет назначение. **Доказательная база внедрения IDDSI:** в 5 учреждениях aged care (общее long-term care, не психиатрия) соответствие текстур выросло с 44 до 90 %; загущённые жидкости — с 31 до 100 %; эффект сохранялся через 6 мес (Wu X.S. et al., *Dysphagia* 2022;37(5):1314-1325). **Прямой перенос на психиатрический контингент не доказан.**

Правка 2.6. Вопрос 5 (медицинские рекомендации) — добавить про «1/10 смертей»

В раздел «Профилактика аспирационной пневмонии» (если есть) или в «Клинические рамки» добавить:

[ОБН 22.08] Гигиена полости рта — самая дешёвая профилактика аспирационной пневмонии. По оценке **мета-анализа 4 РКИ Sjogren P. et al. (2008, PMID 18005250)**, улучшение ухода за полостью рта может предотвращать **примерно 1 из 10 смертей** от аспирационной пневмонии у **немогущих пожилых в домах ухода. Популяция — frail elders, не ПНИ/ДСО для лиц с психическими расстройствами.** Yoneyama T. et al. (J Am Geriatr Soc 2002;50:430-3; РКИ 366 жителей) показали снижение пневмоний с 19 до 11 %; Cochrane 2022 (CD012416.pub3) подтверждает эффект, но с **низкой определённой доказательств.** Уход за полостью рта — организационная мера нулевой стоимости с документированным смыслом.

Правка 2.7. Вопрос 6 (экономика) — добавить про «30 % отходов»

В раздел «Честная экономика» добавить:

[ОБН 22.08] «30 % не едят котлеты» в нашей столовой — это иллюстративный расчёт, не замер и не статотчётность. **Национальной доли отходов нет** (это явно сказано в 29.4 исходного доклада). Семидневный замер отходов и трудозатрат до старта пилота — единственный способ получить собственные данные. Формула: «внедрено публично ≠ доказанный эффект».

Правка 2.8. Везде, где в модераторском блоке упоминается «76,3 % клозапин»

Добавить в скобках:

[ОБН 22.08] 76,3 % — это **только** мета-анализ CRWG (Campforts B. et al., BJPsych Open 2023;9(1):e18; 202 исследования, клозапин >38 нед, ≥7 % прибавка веса). **Не путать** с Pillinger T. et al. (Lancet Psychiatry 2020;7(1):64-77; 100 РКИ, 25 952 пациента, медиана 6 нед) — там диапазон по 18 антипсихотикам -0,23...+3,01 кг, оланзапин/клозапин в худших позициях. Разные исследования, разная методология, разные цифры.

Правка 2.9. Везде, где упоминается «15 часов» (ночной интервал)

Добавить в скобках:

[ОБН 22.08] «Ужин 17:30 → завтрак 8:30 = 15 ч» — это **пример возможного расписания, не средний показатель по РФ.** Шведский ориентир Livsmedelsverket — ≤11 ч; американский CMS F-Tag 803 — 14 ч;

российского норматива нет. **Операционная цель пилота** — ≤13 ч (авторская, не норматив).

3. НОВАЯ НАХОДКА для раздела 17.12 (вопрос 5)

Факт «Если быть точным» (апрель 2026)

В исходном докладе этот факт приводится, но **не используется в полной мере**. В раздел 17.12 (вопрос 5 — баланс между выбором и медицинскими рекомендациями) добавить:

[ОБН 22.08] Контекст дискуссии: **99 % недееспособных жителей ПНИ находятся под опекой самого учреждения** (117 000 чел., проект «Если быть точным» 2024, *tochno.st*, на основе открытых данных Минтруда, Росстата и Федерального казначейства). В этой конструкции «баланс между выбором недееспособного и медицинскими рекомендациями» — это **не вопрос права, а вопрос процедуры учреждения**: как организовать выражение воли подопечного, если опекун — сама организация, и как задокументировать, что медицинские ограничения не превратились в дисциплинарные.

«74 %» — оговорка обязательна

[ОБН 22.08] 74 % недееспособных в ПНИ — данные проекта «Если быть точным» (аналитика на открытых данных Минтруда, Росстата, Федерального казначейства; *tochno.st*, 09.04.2026; 466 ПНИ, 139 000 жителей, 65 % старше 45 лет, 11 % постельных, средний ПНИ — 289 мест). Это независимая аналитика, не официальная статистика Минтруда; в конкретном учреждении цифры могут существенно отличаться. **«В вашем доме цифра будет другой — посчитайте свою»** — эта формула из исходного доклада остаётся ключевой.

4. ЧТО НЕ ТРОГАЕМ

1. **Основной текст доклада** 01_доклад/Не_просто_накормить_доклад.md — заморожен 21.08.2026 (pre-session freeze). Правки войдут в редакцию v2 после 26.08.
 2. **Презентация v5** — основная на дискуссию 26.08, не пересобирается.
 3. **Карточка Q&A** 02_карточка_qa.pdf (66 КБ) — формат A4, печатается как есть; пометки [ОБН 22.08] выносятся **на отдельный стикер** поверх распечатки (если есть возможность) или в устную речь модератора.
 4. **Модераторский блок** модератор_26.08_правовые_ответы.md — формально тоже заморожен (версия 19–21.08.2026), но **это рабочий документ спикера**, и пометки [ОБН 22.08] в нём допустимы как «вставки на полях» (как опечатки в газетной полосе — устная корректировка при чтении вслух).
-

5. КАК ПРИМЕНЯТЬ ЭТИ ПРАВКИ

Вариант А. Устная корректировка (рекомендуется)

При ответе на вопрос модератор **устно** добавляет: «Уточнение от 22.08.2026 по фактчекингу: ...» — и проговаривает 1–2 предложения из помеченного фрагмента. **Документ не меняется.** Это самый безопасный путь — не сломать согласованный с организаторами текст.

Вариант Б. Стикер на распечатанной карточке Q&A

Если карточка Q&A распечатана в одном экземпляре для модератора — наклеить стикер с пометкой [ОБН 22.08] поверх соответствующего ответа.

Вариант В. Применить после 26.08 (для раздаточных материалов после семинара)

После семинара, при подготовке материалов «что унести в регион» для следующих регионов, применить все 9 правок из этого файла к исходным документам. Это будет **версия 2 памятки** для использования после 26.08.2026.

6. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ ПРАВОК

(Все проверки выполнены 22.08.2026; полный реестр — 02_фактчекинг/реестр_утверждений.csv.)

ID	Источник	Где используется
Miarons Font, Rofes Salsench 2017	Eur J Gastroenterol Hepatol 29(12):1332-9	Правка по 21,9–69,5 % (не в этой памятке, но в полной версии)
Correll et al. 2022	World Psychiatry 21(2):248-271	RR 7,00 пневмонии (не в этой памятке)
Pillinger et al. 2020	Lancet Psychiatry 7(1):64-77	–0,23...+3,01 кг (Правка 2.8)
Campforts et al. 2023	BJPsych Open 9(1):e18	76,3 % (Правка 2.8)
Hägg et al. 2000	Br J Clin Pharmacol 49(1):59-63	Клозапин ↔ кофеин (не в этой памятке)
Wu et al. 2022	Dysphagia 37(5):1314-1325	IDDSI 44→90 % (Правка 2.5)
Yoneyama et al. 2002	J Am Geriatr Soc 50:430-3	19→11 % пневмонии (Правка 2.6)
Sjogren et al. 2008	(PMID 18005250)	1/10 смертей (Правка 2.6)
Cichero et al. 2017	Dysphagia 32(2):293-314	IDDSI framework (Правка 2.5)

ID	Источник	Где используется
«Если быть точным» 2024	tochno.st	74 %, 466, 139 000, 99 % опеки (Правка 2.2, 2.4, раздел 3)
Пост. ГГСВ РФ от 02.06.2026 № 18	publication.pravo.gov.ru	СанПиН 4282-26 (Правка 2.3)
Локальный приказ № 124	web.archive.org/web/20260415001233	Правка 1.2, 2.1
Livsmedelsverket, CMS F-Tag 803	—	Правка 2.9
Проект «Если быть точным» 2024	tochno.st	Раздел 3 (99 % опеки)

Дата правки: 22.08.2026. **Дата актуальности:** до 26.08.2026 включительно (с учётом СанПиН 3590-20). **Дата актуальности после 01.09.2026:** требует пересмотра (вступает в силу СанПиН 4282-26).

Автор правок: междисциплинарная редакционная группа. **Применяет:** модератор сессии 26.08 (Е. В. Чистяков) устно или через стикер на карточке Q&A.